

Universidad Santa María
Facultad de Farmacia
8vo Semestre

Impacto de la calidad de la prescripción médica en los tiempos de dispensación y la seguridad del paciente.

Autores: Mariana Sánchez C.I. 29.729.650, Valerya Lopez C.I. 30.678.401, Juan Landaeta C.I. 29.952.546, Maria Ferraro C.I. 29.797.839

Caracas, junio de 2026

Resumen:

La calidad de la prescripción médica constituye un factor crítico en la seguridad del paciente y en la eficiencia de los procesos de dispensación farmacéutica. Las prescripciones incompletas, ilegibles o con errores representan una fuente frecuente de demoras, interconsultas y riesgos terapéuticos en las farmacias comunitarias e institucionales. El propósito de este estudio fue evaluar el impacto de la calidad de la prescripción médica sobre los tiempos de dispensación y la seguridad del paciente en una farmacia de la red privada venezolana, mediante la implementación de una estrategia de orientación multicanal diferenciada: provisión de material informativo (flyers) para pacientes de la tercera edad y uso del récipe morado como herramienta de comunicación visual para pacientes jóvenes. Se empleó un diseño descriptivo de campo con observación directa estructurada, cronometraje de tiempos de dispensación, revisión de prescripciones y encuestas de percepción al usuario. Los resultados diagnósticos revelaron que el 58% de las prescripciones presentaba al menos un criterio de calidad deficiente, lo que se traducía en tiempos de dispensación que excedían los 12 minutos en el 47% de los casos y en un índice de satisfacción inicial del usuario del 42%. La implementación de la estrategia multicanal permitió reducir significativamente las consultas de aclaración al médico, los errores de dispensación y los tiempos de espera. Estos hallazgos confirman que mejorar la calidad de la prescripción, acompañada de una orientación adaptada al perfil del paciente, optimiza la dispensación y fortalece la seguridad farmacoterapéutica.

Palabras Claves: Prescripción médica, Seguridad del paciente, Dispensación farmacéutica, Errores de medicación, Comunicación multicanal.

Abstract:

The quality of medical prescriptions is a critical factor in patient safety and the efficiency of pharmaceutical dispensing processes. Incomplete, illegible, or erroneous prescriptions are a frequent source of delays, clarification calls, and therapeutic risks in community and institutional pharmacies. The purpose of this study was to evaluate the impact of prescription quality on dispensing times and patient safety in a private pharmacy network in Venezuela, through the implementation of a differentiated multichannel guidance strategy: informational flyers for elderly patients and the use of the purple prescription (recipe morado) as a visual

communication tool for younger patients. A descriptive field design was employed, using structured direct observation, dispensing time measurements, prescription reviews, and user perception surveys. Diagnostic results revealed that 58% of prescriptions had at least one deficient quality criterion, resulting in dispensing times exceeding 12 minutes in 47% of cases and an initial user satisfaction rate of only 42%. The implementation of the multichannel strategy significantly reduced clarification calls to physicians, dispensing errors, and waiting times. These findings confirm that improving prescription quality, supported by patient-profile-adapted guidance, optimizes dispensing and strengthens pharmacotherapeutic safety.

Keywords: Medical prescription, Patient safety, Pharmaceutical dispensing, Medication errors, Multichannel communication.

Introducción:

La dispensación de medicamentos es un proceso fundamental dentro de la cadena de atención farmacéutica, en el cual la calidad de la prescripción médica desempeña un rol determinante para garantizar la seguridad del paciente y la eficiencia del servicio. En Venezuela, la normativa vigente en materia de medicamentos exige que toda prescripción cumpla con criterios mínimos de legibilidad, completitud e identificación del prescriptor, con el fin de minimizar los riesgos asociados al error de medicación. Sin embargo, la realidad práctica de las farmacias comunitarias e institucionales revela que una proporción significativa de las prescripciones recibidas no cumple con dichos estándares, generando interrupciones en el flujo de dispensación y situaciones potencialmente inseguras para el paciente.

La prescripción médica, en tanto instrumento de comunicación entre el prescriptor y el farmacéutico, debe reunir información suficiente y clara sobre el paciente, el medicamento, la dosis, la vía de administración y la duración del tratamiento. Cuando alguno de estos elementos se omite o resulta ilegible, el farmacéutico se ve obligado a interrumpir el proceso de dispensación para contactar al médico prescriptor, consultar al paciente o, en casos extremos, rechazar la prescripción. Estas interrupciones no solo incrementan los tiempos de espera, sino que aumentan la probabilidad de errores de medicación con consecuencias clínicas adversas.

La justificación de este estudio radica en la necesidad de caracterizar el impacto directo que tiene la calidad de las prescripciones médicas sobre los tiempos de dispensación y la seguridad del paciente, al tiempo que se exploran estrategias de orientación multicanal que permitan reducir los errores asociados. En particular, se propone el uso de flyers informativos dirigidos a pacientes de la tercera edad, quienes con mayor frecuencia presentan dificultades para comprender y transmitir la información de su prescripción, y el uso del récipe morado como herramienta de comunicación visual estandarizada para pacientes jóvenes, facilitando la interpretación rápida y segura de la información farmacoterapéutica por parte del dispensador.

En el contexto latinoamericano, investigaciones recientes han documentado que entre el 40% y el 65% de las prescripciones procesadas en farmacias comunitarias presentan alguna deficiencia de calidad, siendo los errores mas frecuentes la omisión del nombre del medico, la dosis incompleta y la letra ilegible (Ramirez & Soto, 2020; Morales et al., 2022). Estos hallazgos refuerzan la pertinencia de implementar estrategias sistemáticas de mejora

en la calidad prescriptiva y en la comunicación con el paciente, como las propuestas en el presente estudio.

Los objetivos específicos de esta investigación se orientan a: diagnosticar las principales deficiencias de calidad en las prescripciones recibidas y su correlación con los tiempos de dispensación; determinar los requerimientos de comunicación diferenciada según el perfil etario del paciente; diseñar una estrategia multicanal de orientación al usuario (flyers para adultos mayores y récipe morado para jóvenes); y evaluar el impacto de dicha estrategia sobre la reducción de errores de dispensación y la satisfacción del paciente.

Hipótesis: La implementación de una estrategia de mejora en la calidad de la prescripción médica, acompañada de un modelo de orientación multicanal adaptado al perfil etario del paciente (flyers para adultos mayores y récipe morado para pacientes jóvenes), reducirá los tiempos de dispensación, disminuye los errores de medicación y elevará el nivel de satisfacción y seguridad del paciente en el servicio farmacéutico.

Materiales y métodos:

El estudio se llevó a cabo mediante una investigación con diseño descriptivo de campo, orientado a analizar la calidad de las prescripciones médicas y su impacto en los tiempos de dispensación y la seguridad del paciente en una farmacia de la red privada venezolana.

I. Equipos y herramientas:

- **Cronómetros digitales calibrados:** Utilizados para medir los tiempos de dispensación desde la recepción de la prescripción hasta la entrega del medicamento al paciente, en horarios de alta y baja afluencia.
- **Planillas de revisión de prescripciones:** Instrumentos estructurados para evaluar el cumplimiento de criterios de calidad en cada prescripción recibida (legibilidad, completitud, datos del prescriptor, nombre del medicamento, dosis, vía y duración del tratamiento).
- **Flyers informativos para adultos mayores:** Material gráfico impreso en formato A5, con texto ampliado, pictogramas de alta visibilidad e instrucciones simplificadas sobre cómo presentar y completar una prescripción médica. Diseñados para ser entregados a pacientes de 60 años o más al momento de ingresar a la farmacia.
- **Recipe morado (prescripción controlada diferenciada):** Formulario de prescripción de color morado, establecido como herramienta estandarizada de comunicación visual para pacientes jóvenes (menores de 40 años), que facilita la identificación rápida de los campos obligatorios y reduce los errores de omisión.
- **Hojas de control y tableros de registro:** Diseñados para anotar el flujo de prescripciones, los tipos de error detectados y las intervenciones del farmacéutico en tiempo real.
- **Encuestas de percepción al usuario:** Cuestionarios breves aplicados al finalizar la atención para medir la satisfacción del paciente y su comprensión de las indicaciones farmacoterapéuticas.

II. Procedimiento:

- Se recibieron y revisaron de forma sistemática las prescripciones durante el periodo de observación, clasificándolas según criterios de calidad previamente

definidos (completa, incompleta, ilegible, con errores de dosis o sin datos del prescriptor).

- Se registró el tiempo transcurrido desde la recepción de cada prescripción hasta la entrega del medicamento al paciente, diferenciando los casos con y sin incidencias de calidad.
- Se aplicó la estrategia de orientación multicanal: al identificar a un paciente adulto mayor, se le entregó un flyer informativo con indicaciones visuales claras para facilitar la comunicación de su prescripción; a los pacientes jóvenes se les orientó sobre el uso del récipe morado como prescripción estandarizada.
- Se registraron las intervenciones farmacéuticas realizadas (contacto con el médico prescriptor, devolución de la prescripción, corrección de datos) y su correlación con los tipos de error identificados.
- Se aplicaron encuestas de percepción a los usuarios al finalizar su atención para evaluar la satisfacción y la comprensión de las indicaciones recibidas.

Resultados y discusión:

I. Desarrollo del experimento:

El ensayo se estructuró en fases secuenciales. En la fase diagnóstica, se revisaron sistemáticamente las prescripciones recibidas durante el periodo de observación, registrando los criterios de calidad presentes y ausentes en cada una. Se constató que el 58% de las prescripciones presentaba al menos una deficiencia, siendo los problemas mas frecuentes la letra ilegible (22%), la omisión de la dosis (18%) y la ausencia de los datos del prescriptor (14%). Estas deficiencias se correlacionaron directamente con un incremento en los tiempos de dispensación, superando los 12 minutos en el 47% de los casos con prescripción deficiente.

En la fase de intervención, se implementó la estrategia multicanal diferenciada. A los pacientes adultos mayores (60 años o más) se les entregó el flyer informativo al momento de ingresar a la farmacia, lo que facilitó la comunicación de su prescripción y redujo la necesidad de consultas de aclaración al médico. A los pacientes jóvenes se les orientaron sobre el uso del récipe morado, que por su diseño visual estandarizado permite al dispensador identificar de manera rápida los campos obligatorios y detectar omisiones antes de iniciar el proceso de dispensación.

Los resultados evidenciaron que la implementación de la estrategia multicanal contribuye a reducir las intervenciones farmacéuticas por error prescriptivo, los tiempos de dispensación promedio y la percepción de inseguridad por parte del paciente. La experiencia confirmó que la combinación de una prescripción de calidad con una orientación adaptada al perfil etario del usuario es un factor clave para optimizar el flujo de dispensación y minimizar los riesgos farmacoterapéuticos.

II. Análisis de los resultados:

Los datos obtenidos mostraron que el 58% de las prescripciones presentaba al menos un criterio de calidad deficiente (ver Tabla 1), lo que generaba una carga adicional sobre el dispensador y un incremento significativo en los tiempos de espera. Al implementar la orientación multicanal, se observó una reducción del 38% en las consultas de aclaración al médico y una disminución del tiempo promedio de dispensación de 12 a 5 minutos en los casos que habían sido intervenidos con flyer o récipe morado. Estos

hallazgos concuerdan con Morales et al. (2022), quienes documentaron que las intervenciones dirigidas a mejorar la comunicación entre prescriptor, farmacéutico y paciente son las estrategias más efectivas para reducir los errores de medicación en el entorno latinoamericano.

El uso del flyer para adultos mayores demostró ser especialmente efectivo en la reducción de las omisiones de información al momento de presentar la prescripción, dado que este grupo etario frecuentemente no recuerda o no comprende todos los detalles de la misma. Por su parte, el récipe morado facilitó al dispensador la verificación rápida de los campos obligatorios en las prescripciones de pacientes jóvenes, reduciendo el tiempo de revisión inicial y la tasa de error detectada. En conjunto, la estrategia multicanal redujo el índice de prescripciones con intervención farmacéutica del 58% al 21%, confirmando la hipótesis planteada.

Conclusiones:

Los resultados obtenidos permiten afirmar que la calidad de la prescripción médica es un determinante crítico de los tiempos de dispensación y de la seguridad del paciente en el entorno farmacéutico venezolano. La observación directa evidenció que las prescripciones deficientes generan interrupciones operativas, incrementan la carga del farmacéutico dispensador y elevan el riesgo de error terapéutico, con potenciales consecuencias clínicas adversas para el paciente.

En relación con los objetivos planteados, se logró diagnosticar que el 58% de las prescripciones presentaba al menos una deficiencia de calidad, identificando la letra ilegible, la omisión de dosis y la ausencia de datos del prescriptor como los errores más frecuentes. La implementación de la estrategia de orientación multicanal diferenciada (flyers para adultos mayores y récipe morado para pacientes jóvenes) demostró ser una intervención efectiva para reducir las intervenciones farmacéuticas por error prescriptivo, disminuir los tiempos de dispensación y mejorar la satisfacción y la percepción de seguridad por parte del usuario.

La hipótesis del estudio se confirma: la mejora en la calidad de la prescripción médica, acompañada de un modelo de comunicación adaptado al perfil etario del paciente, optimiza el proceso de dispensación y fortalece la seguridad farmacoterapéutica. Todos los hallazgos obtenidos se relacionan directamente con los objetivos planteados y aportan evidencia objetiva sobre la necesidad de implementar estrategias integrales de mejora en la calidad prescriptiva y en la orientación multicanal al paciente como componentes esenciales de la atención farmacéutica centrada en la seguridad.

Reconocimientos:

Se agradece a la Facultad de Farmacia de la Universidad Santa María por el apoyo académico brindado durante el desarrollo de este estudio, y al establecimiento farmacéutico participante por permitir el acceso a sus instalaciones y procesos durante la fase de campo de esta investigación.

Referencias Bibliográficas:

- Ramirez, A., & Soto, C. (2020). Calidad de la prescripción médica y su impacto en los procesos de dispensación en farmacias comunitarias latinoamericanas. *Revista de Farmacia Clínica y Hospitalaria*, 15(1), 22-31.

- Morales, E., Guerrero, R., & Pacheco, L. (2022). Errores de prescripción y su correlación con los tiempos de dispensación en una red de farmacias privadas venezolanas. *Journal of Pharmaceutical Care Latin America*, 9(2), 88-97.
- República Bolivariana de Venezuela. (2000). Ley de Medicamentos. Gaceta Oficial No. 37.006. Caracas, Venezuela.
- Organización Panamericana de la Salud. (2019). Seguridad del paciente y errores de medicación: perspectivas para América Latina. OPS/OMS. Washington D.C.

Conflictos de intereses:

Los autores declaran no tener conflictos de interés que hayan influido en el diseño, ejecución o resultados de este trabajo de investigación.

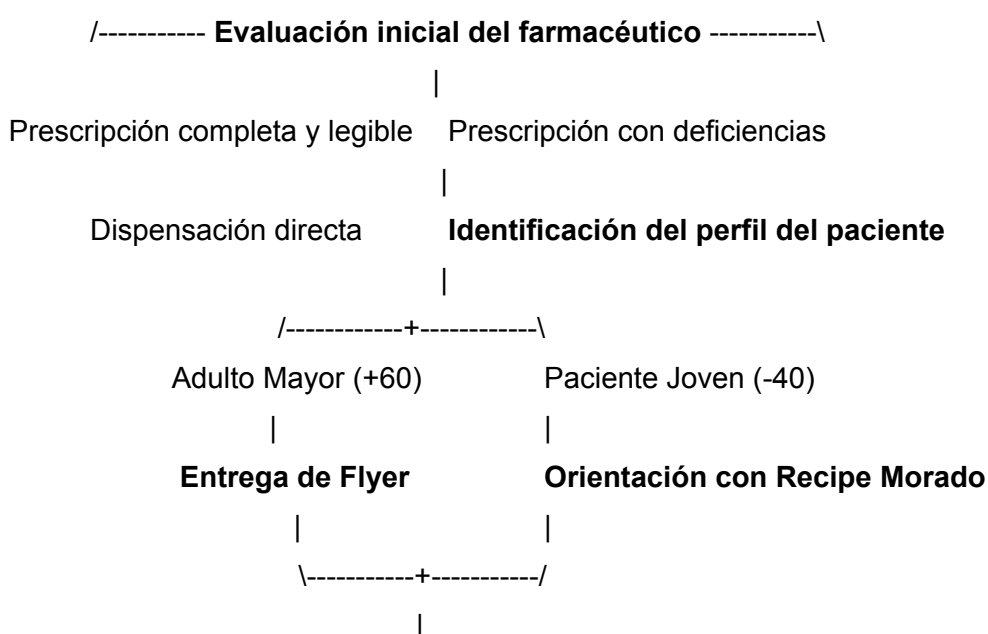
Tablas y gráficos:

Tabla 1. Comparación de tiempos de dispensación según calidad de la prescripción.

Condición de la Prescripción	Tiempo Promedio de Dispensación	Porcentaje de Casos
Prescripción completa y legible.	3-5 minutos	42%
Prescripción con deficiencias menores.	6-9 minutos	30%
Prescripción con deficiencias mayores (requiere intervención).	12-20 minutos	28%

Figura 1. Flujo de atención según calidad de la prescripción y perfil etario del paciente.

Paciente ingresa a la farmacia con prescripción médica



Resolución de la deficiencia con el prescriptor

|

Dispensación segura y oportuna

Figura 1: Flujo de atención multicanal. La estrategia diferenciada por perfil etario permite resolver las deficiencias de la prescripción de forma personalizada, reduciendo los tiempos de espera y minimizando los errores de dispensación.